SDD 125 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatrie

Date : 12/11/2023
Auteur : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES de médecine interne - ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	ITEM 64 Trouble bipolaire
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 125 Humeur exaltée
Matériel nécessaire à la station	Une feuille de note Un stylo
Contexte de la station	Patiente venue pour évaluation d'une suspicion de trouble bipolaire

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un.e psychiatre libéral.e. Vous recevez Mme. Chrismi, 27 ans, pour une suspicion d'un trouble de l'humeur.

Son médecin traitant vous l'envoie car il suspecte un trouble bipolaire de type 2. Devant un épisode dépressif caractérisé diagnostiqué récemment, il a mis en place un traitement par antidépresseur. Mais ce dernier a été mal supporté par la patiente, et le médecin traitant a orienté la patiente vers vous.
Dans le courrier, il vous informe qu'elle n'a pas de traitement actuellement, ni d'antécédent personnel notable. Il y a un antécédent de bipolarité de type 1 chez la tante. Ce courrier date d'il y a 1 mois.

La patiente arrive dans votre bureau de consultation. Elle semble de bonne humeur et pleine d'énergie. Vous confirmez avec elle l'absence de traitement et d'antécédent personnel, et la présence d'un trouble bipolaire chez la tante. Vous vous apprêtez à l'interroger.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Interrogez la patiente sur sa symptomatologie maniaque.
- Enoncer à l'examinateur votre diagnostic en le justifiant avec les éléments cliniques et de l'interrogatoire du patient

Vous ne devez pas :

- Questionner quant à des suspicions de précarité.
- Questionner sur une symptomatologie dépressive.
- Questionner sur les antécédents personnels et familiaux, les allergies, les traitements et le parcours de soin (médical ou psychiatrique).
- Mettre en place un traitement immédiat.
- Expliquer la prise en charge possible du trouble suspecté.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Interrogatoire			
1.	Questionne sur le vécu psychoaffectif (au moins un des 4 éléments) : ● Questionne l'humeur de la patiente ● Questionne les émotions de la patiente ● Questionne sur l'estime de soi ● Questionne le contenu de la pensée de la patiente	1 pt	☐
2.	Questionne sur la sensation d'énergie de la patiente	1 pt	☐
3.	Questionne sur l'attention oula vigilance ou La concentration	1 pt	☐
4.	Questionne sur les activités en denamandant au moins un des éléments suivants : ● Demande si fait plus d'activité actuellement (hyperactivité avec un but) ● Demande si la personne à besoin de bouger plus sans but précis (hyperactivité sans but)	1 pt	☐
5.	Questionne sur les aptitudes communicationnelles	1 pt	☐
6.	Questionne sur le sommeil (demande les 2 éléments) : - Demande le nombre d'heures de sommeil moyen - Demande si ressens de la fatigue	1 pt	☐
7.	Questionne sur l'alimentation de la patiente, en demandant au moins 2 des éléments suivant sur les 3 : - Demande si la patiente a une sensation de faim - Questionne sur la quantité d'aliment prise ET le nombre de repas fait dans la journée - Demande si modification du poids récemment	1 pt	☐
8.	Questionne sur la sexualité de la patiente ET ne relance pas la patiente suite au refus de parler	1 pt	☐

<table>
<tr><td>9.</td><td>Demande si les proches de la patiente lui ont fait des remarques</td><td>1pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Demande depuis environ combien de temps la patiente ressent ces symptômes actuels</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Demande si a déjà eu des épisodes similaire auparavant</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Demande si les symptômes ont un impact sur l’activité professionnelle OU sur les activités sociales</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observation clinique notée sur la feuille</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Les termes sémiologiques observés par l’étudiant.e sur la patiente qui doivent être notés sur la feuille en lien avec la parole (doit mettre les 2 éléments) :
● Tachyphémie
● Logorrhée
Des éléments autres notés en plus n'apportent pas de point.</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Les termes sémiologiques observés par l’étudiant.e sur la patiente qui doivent être notés sur la feuille en lien avec la l’attitude (doit mettre les 2 éléments) :
● Hypermimie
● Agitation motrice/hyperactivité motrice</td><td>1 pt</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Note le diagnostic sur la feuille (doit noter les 2 éléments)
● Trouble bipolaire
● De type 2 (valable que si a bien demandé le temps de durée des symptômes qu’elle ressent actuellement)</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair
<table>
<tr><th>Performance Insuffisante
0 point</th><th>Performance Limite
0,25 point</th><th>Performance Satisfaisante
0,5 point</th><th>Performance Très Satisfaisante
0,75 point</th><th>Performance Remarquable
1 point</th></tr>
<tr><td>Interrompt le patient /pair de façon inappropriée

Ignore les réponses du patient/collègue</td><td>Se montre impatient</td><td>Est attentif aux réponses du patient/pair</td><td>Est attentif aux réponses du patient/pair

Adopte la technique de reformulation si l’information est imprécise ou éloignée des objectifs.</td><td>Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.</td></tr>
</table></td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>2.</td><td>

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

</td><td>1 pt</td><td>☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL (max 20 items)</td><td colspan="2">X/ 20 points</td></tr>
</table>

<u>Éléments de rétroaction :</u>

- Je tiens à préciser que la patiente de cet ECOS est TRÈS caricaturale dans un but pédagogique . Bien que j'ai essayé de rendre le personnage un petit peu sympa, j'espère pour autant ne pas avoir été offensant. Si jamais cela vous semble moqueur ou discriminant, je vous présente mes excuses ce n'était pas l'objectif…
- Les patients en phase maniaque peuvent être compliqués à interroger quand ils ont une humeur élevée. Ils peuvent vite changer de sujet (coq à l'âne) ou parler très vite (logorrhée) par exemple. Cela peut prendre très longtemps si on ne les coupe pas quand iels digressent… Je vous donne plusieurs astuces à connaître pour couper votre patient.e sans être offensant :
    - NE PAS S'AGACER, ÊTRE AGRESSIF… Pire chose à faire car ce n'est pas la faute du patient, et vous risquez aussi de rendre votre patient agressif si vous ne faites pas attention à votre comportement et vos paroles.
    - Ne pas hésiter à couper le/la patient.e si vous donne trop d'information non lié à interrogatoire. Quelque petit conseil pour couper le patient :
        - Expliquez pourquoi vous coupez le/la patient.e : "Attendez attendez, je crois qu'on est en train de s'éloigner du sujet principal".

- N'hésitez pas à vous excuser de couper "Excusez-moi je vous coupe car on est en train de changer de sujet et je voudrais rester sur l'interrogatoire de vos symptômes"...
- Dire que vous coupez dans le but de rester concentré sur les symptômes du patient.

- Un élément TRÈS important à ne pas oublier est si les proches ont fait des remarques précises au/à la patiente sur les domaines où on l'interroge. En effet, il est possible que l'insight de la/le patient.e soit faible , mais que les proches aient pu constater et faire remarquer certains symptômes. Savoir aussi chercher lorsque le/la patiente se qualifie d'une certaine façon si c'est une conclusion qu'iel à fait d'iel-même ou si c'est dû à des remarques qui lui ont été faites. En questionnant sur les remarques faites par les proches, on peut mettre en évidence :

- Des symptômes que l'on peut parfois (pas tout le temps) nous même identifier dans notre interaction avec la patiente (Accélération motrice et comportementale, difficulté d'attention)
- Des symptômes niés par le/la patient.e
- Des éléments qu'on ne peut pas observer lors de l'échange avec la patiente (perturbation physiologique notamment) qui peuvent ne pas être communiqués par le/la patiente si n'a pas conscience du problème/trouble.

- Il existe plusieurs domaines que vous devez interroger pour trouver des symptômes d'une phase maniaque :

Perturbation psycho-affective	Humeur	- Humeur élevée/exalté/euphorique/ « gaie », parfois avec irritabilité - Subjectif pas toujours agréable pour le sujet
	Emotion	- Labilité émotionnelle - Hyperesthésie (émotion trop intense) - Hypersyntonie (adhésion rapide à l'ambiance et émotion des autres)
	Contenu de pensée	- Estime de soi augmenté, idée de grandeur, mégalomanie - Altération/absence conscience du trouble
Perturbation psychomotrice	Cours de la pensée	- Tachypsychie (accélération des pensées) - Pensée diffluente, fuite idée - Coq-à-l'âne (change vite d'idée sans lien) - Jeux de mot, ludisme, association par assonance
	Altération cognitive	- Hypervigilance - Distractibilité, altération attention et concentration
	Accélération motrice et comportement	- Agitation motrice, hyperactivité souvent stérile - Augmentation d'énergie : Activité à but dirigé (pro, sociales ou sexuelles) - Logorrhée (débit parole en flot incoercible et rapide), Tachyphémie (vitesse parole) - Hypermimie (expressions du visage) - Désinhibition (contact familier)

Perturbation physiologique	Sommeil et rythme circadien	- Insomnie partielle/totale - Baisse temps de sommeil avec absence de sensation de fatigue
	Conduite alimentaire	- Anorexie, hyperphagie - Amaigrissement (même si prise alimentaire) - Possible déshydratation
	Sexualité	- Majoration désir/excitation sexuelle - Hypersexualité (comportement à risque)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Mme Chiami, 27ans, vient pour suspicion d'un trouble bipolaire. Envoyé par son médecin traitant suite à un épisode dépressif ayant mal réagi à un traitement par antidépresseur.
Vous arrivez en consultation en phase maniaque : pleine d'énergie, bavarde, bougeant beaucoup. Vous confirmez avec le médecin que vous ne prenez aucun traitement, n'avez pas d'antécédent personnel, et qu'il y a un antécédent familial de trouble bipolaire chez votre tante.
Le médecin s'apprête à vous interroger.

Plan de la station ECOS :

Patient.e face à l'étudiant.e de part et d'autre d'un bureau

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

- Très bien interrogez moi je vous dirai ce que vous souhaitez, après tout je suis là pour ça (rire). Pardon je parle trop. Si je change de sujet, n'hésitez pas à me couper pour recentrer la discussion.

Identité du patient :

Mme Chrismi, 27ans, 1m59, 49 kg, travaille dans la restauration.

Mode de vie :

- Travail dans la restauration
- En couple avec sa petite amie, pas d'enfant
- Vit dans un appartement avec sa compagne
- Ne fume pas
- Consommation d'alcool quotidienne avec ces collègues après le travail au restaurant. 2 verres par jour d'alcool "non fort" (du rosé). Pas d'alcool quand on ne travaille pas, sauf si sortie en bar où boit des bières, sans trop savoir combien.

Comportement global :

On souhaite que l'étudiant.e identifie dans votre comportement (car est évalué.e à le reconnaître) :

- Une "agitation motrice": bouger vos bras quand vous parlez si possible
- Tachyphémie : parler vite
- Logorrhée : vous ne vous arrêtez pas de parler
- Une hypermimie : Faire des expressions faciales très expressives

- Au niveau global, vous devez imiter un.e patient.e excité.e, plein.e d'énergie.

Antécédents personnels :

- Un épisode dépressif caractérisé, diagnostiqué il y a deux ans. Mise sous antidépresseur qu'elle à très mal supporté

Antécédents familiaux :

- Antécédent familial de bipolarité chez la tante maternelle

Médicaments :

Pas de traitement

Symptômes positifs :

Les textes en vert italique sont des textes durant lesquels l'étudiant.e doit vous

couper car l'humeur augmentée fait que vous changez de sujet rapidement.

- Si l'étudiant.e vous demande : " C'est-à-dire comment je me sens ? Je pourrais vous répondre de plein de façon différente n'est ce pas ? Pardon je vous écoute"

- Si l'étudiant.e vous demande comment est l'humeur/le vécu des émotions : "Je me sens très variable, là actuellement mes émotions sont démultipliées, je suis parfois même très irritable. *L'autre jour mon amie Perrine m'a posé une question sur ma copine et je sais pas pourquoi je me suis énervée c'était pénible.*"

- Si l'étudiant.e vous demande quelle sont les contenus de ces pensées : "Il y en a trop trop trop et elles vont si vite. Surtout que y a plein de sujets qui fusent sans aucun lien logique. T*out à l'heure j'étais dans le bus pour venir ici avec la ligne 12, celle qui a le bandeau vert, et je checkais mon compte en banque et là je me suis demandé si les singes savaient utiliser les téléphones,je sais pas pourquoi… Enfin si je sais pourquoi j'ai lu un article dessus… Mais ce n'est pas le sujet"*.

- Si l'étudiant.e vous demande si vous sentez que vous avez plus d'énergie : " Olala oui je suis sur ressort ces derniers temps je saute partout je fais 800 trucs en même temps. *L'autre jour je suis allé faire mon marché et j'étais tellement pleine d'énergie que j'ai porté 3 sac de terre de 10kg pour en ramener à ma voisine qui en manque ces derniers temps.*"

- Si l'étudiant.e demande au niveau du sommeil comment vous dormez : "très peu, très très très peu, souvent moins de 5h parfois moins de 3h."

- Si l'étudiant.e vous questionne sur votre estime de vous : "Ah actuellement je peux tout faire vraiment il n'y a rien que je ne puisse pas faire, je me sens toute puissante. Je vous ai raconté quand j'ai porté toute seule les 3 sacs de terre de 10kg jusqu'à chez ma voisine ? Oui parce que elle n'en avait plus la pauvre donc j'ai voulu aider cette pauvre Simone."

- Si l'étudiant.e vous questionne sur la communication avec ces proches : " je parle beaucoup, je parle tout le temps ces derniers temps. Mon patron m'a dit que je parle trop avec les clients, et qu'il préfère encore quand je suis déprimée car je parle peu et je perds moins de temps"

- Si l'étudiant.e vous questionne sur votre attention : "Je suis très facilement distraite ces derniers temps. Un papillon qui passe, une voiture qui klaxonne, une personne qui parle, tout cela me distrait quand je parle avec mes amis"

- Si l'étudiant.e vous questionne sur votre sexualité : "Je ne suis pas très à l'aise de parler de cela avec vous, mais elle est normale"

- Si l'étudiant.e vous questionne sur votre alimentation : "Rien de particulier pour tout vous dire je mange normalement en faisant très attention. *Je veux vraiment pas prendre de poids, donc je fais du sport, avec salle tous les*

mercredi, course le jeudi avec ma copine, cross-fit le vendredi, samedi et dimanche avant de sortir en soirée je fais aussi des pompes et des abdos"

- Si l'étudiant.e vous questionne sur la durée de vos symptômes : "Je me sens comme cela depuis 5 jours, mais cela devrait bientôt passer. Je me connais je sens que ça redescend, je suis assez sûre de moi la dessus"

- Si l'étudiant.e vous questionne sur si vous avez déjà eu des épisodes similaires : "Oui cela m'arrive d'en avoir, mais ça dure toujours moins de 1 semaine."

Réponse sur le retentissement vie pro et et perso :
- Si l'étudiant.e vous questionne sur des problèmes dans votre vie professionnelle : "Mon patron est très en colère car je parle trop avec les clients, mais sinon il aime bien le fait que je sois aussi active, que je fasse plus d'heures ces derniers temps"
- Si l'étudiant.e vous questionne sur des problèmes au niveau personnel : "Mes proches m'ont fait des remarques sur le fait que je parlais beaucoup et très vite, que je suis trop sociable avec des inconnus aussi, même si je trouve qu'ils exagèrent"
- Si vous demande qui sont les proches dont vous parlez : "Ah je vous parle de ma famille, mes amis et mes collègues"

Questions de relance :

- Si l'étudiant.e ne vous coupe pas pour les 2 premières questions pendant que vous dites la partie en vert italique, dire : "n'hésitez vraiment pas à me couper, je parle trop en ce moment, sinon on ne va pas avoir le temps de faire tout"

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

- Candidat.e et acteur.trice face-à-face de part et d'autre d'un bureau
- Une feuille de notation TACFA (fourni avec le sujet) posé sur la table avec un stylo